

Sen po traumie

70–90% osób z PTSD ma zaburzenia snu — i sam sen jest mechanizmem podtrzymującym objawy. Naprawa snu jest często pierwszą fazą terapii, której efekt widać szybko.

CZAS: stała praktyka Pierwsza linia interwencji

ŹRÓDŁO: Germain (2013); Spoormaker & Montgomery (2008)

JAK UŻYWAĆ

Sen po traumie zaburzony jest na **czterech poziomach**: bezsenność (trudność zaśnięcia + przebudzenia), **koszmary**, **fragmentaryczność** (krótsze cykle), **zmniejszona ilość snu głębokiego** i REM. Każdy z tych poziomów wymaga innego podejścia: bezsenność — higiena snu + CBT-I, koszmary — IRT lub prazosyna, fragmentaryczność — protokół rytmu dobowego, sen głęboki — eliminacja alkoholu i nadgodzin. Ta karta zbiera **10 zasad**, których łączny efekt poprawia sen u 60–70% pacjentów w 4–8 tygodni — często *przed* rozpoczęciem ekspozycji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Germain (2013) w przeglądzie systematycznym pokazała, że **zaburzenia snu nie są tylko objawem PTSD — są też jego mechanizmem**. Sen REM jest niezbędny do konsolidacji pamięci i integracji emocji. Fragmentaryczny sen REM po traumie *uniemożliwia* mózgowi przetworzenie wspomnień. Tworzy się błędne koło: trauma → koszmary → fragmentaryczny sen → brak konsolidacji → koszmary znowu. Spoormaker (2008) wykazał, że **poprawa snu** sama w sobie obniża inne objawy PTSD — flashbacki, drażliwość, koncentrację. Praktyczna konsekwencja: **nie czekaj z pracą nad snem do końca terapii**. To pierwsza linia, często z szybkim efektem.

01 10 zasad — protokół snu po traumie

1 · STAŁA PORA WSTANIA

Co dzień ta sama, ± 30 min, *nawet w weekend*. To kotwica rytmu dobowego.

2 · STAŁA PORA KŁADZENIA

Cofnij się o 8 godzin od pory wstania. Rytuał wieczorny 30 min wcześniej.

3 · BEZPIECZNE ŚWIATŁO NOCNE

Nie pełna ciemność. Lampka pozwala szybko zorientować się po przebudzeniu — redukuje lęk.

4 · BEZ ALKOHOLU WIECZOREM

Pozornie pomaga zasnąć, ale fragmentuje sen w drugiej połowie nocy i **wzmaga koszmary**.

5 · BEZ KOFEINY PO 14

Okres półtrwania 5–6 godzin. Kawa o 16 = aktywny metabolit o 22.

6 · ŁÓŻKO = TYLKO SEN

Bez pracy, jedzenia, oglądania w łóżku. Bezsenność po 20 min — wstań, krótko czytaj, wróć przy senności.

7 · BEZ EKRANÓW GODZINĘ PRZED

Niebieskie światło hamuje melatoninę. Telefon poza sypialnię. Budzik fizyczny.

8 · BRAK INTENSYWNYCH TREŚCI

Wiadomości, thrillery, dramaty — 2 h przed snem. Wybieraj treści spokojne, znane.

9 · RUCH W CIĄGU DNIA

30 min aerobowego ruchu codziennie poprawia sen głęboki. Najlepiej rano lub po południu, *nie* 2 h przed snem.

10 · PLAN NA KOSZMAR

Wiesz, co robisz po przebudzeniu (osobny handout). Sam plan obniża antycypacyjny lęk.

02 🕒 Leki na sen w PTSD — krótka mapa

ROZWAŻANE PRZEZ PSYCHIATRĘ

Prazosyna — na koszmary po traumie. Specyficzny lek o silnych dowodach (Raskind 2018). **Trazodon** — na bezsenność. **Melatonina** — regulacja rytmu dobowego.

UNIKAĆ

Benzodiazepiny (np. klonazepam) — pozornie pomagają, ale *blokuja efekt ekspozycji* i ryzyko uzależnienia. **Z-leki** (zolpidem, zopiklon) — ostrożnie, krótkoterminowo.

Ważne: CBT-I (terapia poznawczo-behawioralna bezsenności) ma *wiekszy efekt* niż leki w długim terminie. Rozważ z psychiatrą.

03 📅 Mój audyt snu · 2 tygodnie

DZ.	PORA SNU godz.	PORA WSTANIA godz.	SEN godz.	PRZEBUDZEŃ liczba	JAKOŚĆ 0–10	CO PRZESZKADZAŁO
Pn						
Wt						
Śr						
Cz						
Pt						
Sb						
Nd						

Klucz: w retrospektywnych obserwacjach Spoormaker (2008) *poprawa snu* u pacjentów z PTSD niezależnie od innych interwencji wiązała się z 25–35% redukcją objawów ogólnych. Sen jest fundamentem konsolidacji pamięci — bez snu terapia ekspozycyjna ma mniejszy efekt. Higiena snu w PTSD nie jest „uzupełnieniem”, lecz pierwszą interwencją.